二、胆囊结石

（一）胆囊结石的临床表现

3F:Female Forty Fat

1.多见于 **3F 人群（女性、＞40 岁、肥胖）**雌激素抑制胆囊收缩

与平滑肌痉挛有关,平滑肌"不摆烂"　迷走N张力高　平滑肌需要休息　VS 胰腺炎:向左肩放射

2.典型表现——**胆绞痛**：饱餐特别是油腻食物后、或夜间出现右上腹绞痛，呈阵发性，可向右肩和背部放射

没影响胆汁排泄

3.**无黄疸**、**无胆囊增大**　胆囊强烈收缩→可能让结石移位,刚好嵌顿在胆囊颈,胆囊排空受阻→胆囊平滑肌强有力收缩

阵发性绞痛:警惕机械性肠梗阻、胆系结石、输尿管结石

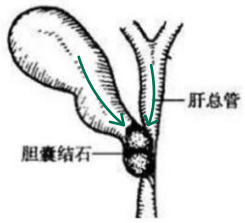
4.位于颈、管的结石可致：

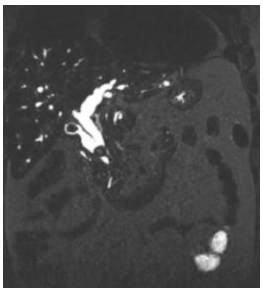


①胆囊梗阻：胆囊积液、胆囊增大、白胆汁　胆色素逐渐被胆囊黏膜吸收　胆汁排不走

②**Mirizzi 综合征**：胆囊管与肝总管伴行过长、或两者汇合位置过低，持续嵌顿在胆囊颈、管的结石压迫肝总管致其狭窄，表现为反复发作的胆囊炎、胆管炎、黄疸，可见胆囊增大、肝总管扩张、肝内胆管可扩张，但**胆总管不扩张**（M 像伴行）被压到肝总管狭窄,被压迫位置上方的肝总管扩张







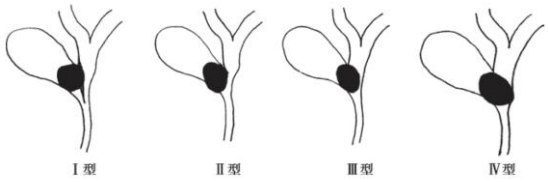


图 44-9 Mirizzi 综合征

Csendes 分型：Ⅰ型：外压导致胆总管部分或全部梗阻，但没有瘘管形成；Ⅱ型：胆囊胆管瘘，累及周径不超过 1/3；Ⅲ型：胆囊胆管瘘，累及周径超过 1/3 但不超过 2/3；Ⅳ型：胆囊胆管瘘，累及周径超过 2/3。

管道思路:找到梗阻点,梗阻点及其上方就会有相应扩张

（二）胆囊结石的并发症 一般全选

1.急性胆囊炎（胆囊壁增厚＞4mm）

2.慢性胆囊炎（胆囊壁增厚＞3mm）

3.胆囊癌：70%的胆囊癌合并胆囊结石。≥2cm 的结石有诱发胆囊癌的可能、3cm 的结石并发胆囊癌的比例是 1cm 结石患者的 10 倍

4.胆总管结石：小结石经胆囊管进入胆总管而形成，可并发黄疸、胆管炎、胆管癌、急性胰腺炎等

小石头不会导致肠梗阻

5.胆石性肠梗阻：胆囊炎慢性穿孔→胆囊-十二指肠/结肠瘘→大结石经瘘管进入肠道。首选 X 线

